



Unidade : Nossa Senhora Graças

Exame nº 25/B09160 ***

Nome : Jose Valmir Rosa
Origem : (I)
Requis. : Dr. Luiz Augusto Bendhack
CRM : 12585PR

Data Nasc. : 17/08/1942
Data Coleta : 18/06/2025
Data Cadastro : 20/06/2025
Prontuario : 5513889

Conv. : Unimed-Int. - ESG Aut:1427403942

Matríc. : 00320000034625100

Procedimento(s):

Próstata:

Biópsia Simples, Bloco Citológico, Imprints

4.06.01.11.0 x 6

Relatório Médico:

Macroscopia:

Data: 24/06/2025

- 1 - Dois fragmentos filiformes de tecido rotulado como de próstata - ápice direita, o maior com 1,5 cm em comprimento e 0,1 cm de diâmetro, esbranquiçado, macio, elástico e fosco. 1/2 TI.
- 2 - Três fragmentos filiformes de tecido rotulado como de próstata - médio direita, o maior com 1,4 cm em comprimento e 0,1 cm de diâmetro, esbranquiçado, macio, elástico e fosco. 1/3 TI.
- 3 - Quatro fragmentos filiformes de tecido rotulado como de próstata - base direita, o maior com 1,8 cm em comprimento e 0,1 cm de diâmetro, esbranquiçado, macio, elástico e fosco. 1/4 TI.
- 4 - Quatro fragmentos filiformes de tecido rotulado como de próstata - ápice esquerda, o maior com 1,9 cm em comprimento e 0,1 cm de diâmetro, esbranquiçado, macio, elástico e fosco. 1/4 TI.
- 5 - Três fragmentos filiformes de tecido rotulado como de próstata - médio esquerda, o maior com 2,3 cm em comprimento e 0,1 cm de diâmetro, esbranquiçado, macio, elástico e fosco. 1/3 TI.
- 6 - Quatro fragmentos filiformes de tecido rotulado como de próstata - base esquerda, o maior com 1,5 cm em comprimento e 0,1 cm de diâmetro, esbranquiçado, macio, elástico e fosco. 1/4 TI.

Microscopia:

Data: 25/06/2025

Cortes histológicos corados por hematoxilina-eosina demonstram fragmentos teciduais com características arquiteturais e celulares que corroboram o diagnóstico a seguir:

Conclusão:

Data: 25/06/2025

1- Biópsia de próstata - ápice direito:

- AUSÊNCIA DE NEOPLASIA, NESTA AMOSTRA.

2- Biópsia de próstata - médio direito:

- AUSÊNCIA DE NEOPLASIA, NESTA AMOSTRA.
- ATROFIA ACINAR PROSTÁTICA.

3- Biópsia de próstata - base direito:

- FOCO DE PROLIFERAÇÃO ATÍPICA DE PEQUENOS ÁCINOS (ASAP).

4- Biópsia de próstata - ápice esquerdo:

- FOCO DE PROLIFERAÇÃO ATÍPICA DE PEQUENOS ÁCINOS (ASAP).

5- Biópsia de próstata - médio esquerdo:

- ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO, ESCORE DE GLEASON 7 (3+4).
- GRUPO PROGNÓSTICO 2 (ISUP).
- Porcentagem de Gleason 4: 25%.

"O diagnóstico anatomopatológico é ato médico complexo e sua interpretação deve ser feita pelo médico assistente sempre inserindo-o no contexto clínico da doença em investigação e relacionando aos demais exames complementares (Resolução 1823/2007 do CFM e SBP 93/2010)."

"De acordo com a legislação em vigor (CCB/2002 e CDC) este serviço fará a guarda de blocos e lâminas por 10 anos a partir da data do diagnóstico."

Responsável Técnico: Dra. Lúcia de Noronha, CRM 14547

Pessoa Jurídica inscrito sob CRM 0000341 - PR



- Padrão cribiforme: ausente.
- Carcinoma intraductal: não detectado.
- O tumor envolve cerca de 55% do tecido analisado (acometendo 3 de 3 fragmentos analisados, com extensão linear máxima de aproximadamente 8,0 mm).
- Invasão perineural: presente.
- Invasão angiolinfática: não detectada.

6- Biópsia de próstata - base esquerdo:

- ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO, ESCORE DE GLEASON 7 (3+4).
- GRUPO PROGNÓSTICO 2 (ISUP).
- Porcentagem de Gleason 4: 20%.
- Padrão cribiforme: ausente.
- Carcinoma intraductal: não detectado.
- O tumor envolve cerca de 55% do tecido analisado (acometendo 4 de 4 fragmentos analisados, com extensão linear máxima de aproximadamente 10,0 mm).
- Invasão perineural: presente.
- Invasão angiolinfática: não detectada.

Adendo: A biópsia por fragmentos é uma amostra parcial da lesão alvo podendo, por vezes, haver alterações quanto ao grau histológico e/ou tipo histológico quando da análise do espécime cirúrgico in toto.

Referências Bibliográficas:

- The 2019 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Grading of Prostatic Carcinoma.
- Protocol for the Examination of Prostate Needle Biopsies From Patients With Carcinoma of the Prostate Gland: Specimen Level Reporting. College of American Pathologists. 2021.
- The 2022 World Health Organization Classification of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organ.

Observação: Caso submetido à CONSULTORIA INTERNA sendo revisado pela Dra. Elizabeth Schneider Gugelmin, CRM 7828 que corrobora o diagnóstico emitido.

Curitiba, 25/06/2025

Dra. Samya Hamad Mehanna
CRM: 33363-PR 28458

"O diagnóstico anatomopatológico é ato médico complexo e sua interpretação deve ser feita pelo médico assistente sempre inserindo-o no contexto clínico da doença em investigação e relacionando aos demais exames complementares (Resolução 1823/2007 do CFM e SBP 93/2010)."

"De acordo com a legislação em vigor (CCB/2002 e CDC) este serviço fará a guarda de blocos e lâminas por 10 anos a partir da data do diagnóstico."

Responsável Técnico: Dra. Lúcia de Noronha, CRM 14547

Pessoa Jurídica inscrito sob CRM 0000341 - PR